

Cykl *epizodu*

Każdy epizod ma swoją krzywą: prodrom — narastanie — szczyt — ustępowanie — powrót do bazy. Znajomość własnego cyklu pomaga reagować w odpowiednim momencie, nie za późno i nie za wcześnie.

CZAS: 30 min — wypełnienie Po 1-3 epizodach **ŹRÓDŁO:** Mansell i wsp. (2007); Basco & Rush (2005)

JAK UŻYWAĆ

Epizod ChAD **nie wybucha nagle** — rozwija się fazowo. Pięć typowych faz: **prodrom** (subtelne zmiany 1-4 tygodnie przed), **narastanie** (objawy stają się wyraźne), **szczyt** (pełnoobjawowy epizod), **ustępowanie** (objawy słabną, ale stan nie jest jeszcze stabilny), **powrót do eutymii** (stabilizacja). Każda faza ma *swój priorytet interwencyjny*: w prodromie wystarczy korekta zachowań, w szczycie często potrzebna jest hospitalizacja. Twoim zadaniem na tej karcie jest zmapować, jak typowo wygląda *Twój* cykl.

DLACZEGO TO DZIAŁA

Mansell i wsp. (2007) w modelu integratywnym pokazali, że interpretacja zmian afektywnych (ang. *integrative cognitive model*) decyduje o tym, czy łagodne zmiany przerodzą się w pełny epizod, czy zostaną „zatrzymane” wcześniej. Pacjent, który *rozpoznaje* początek narastania jako „ucieający rytm dobowy” i włącza protokół snu, ma o 40-50% niższe ryzyko progresji do pełnego epizodu w porównaniu z pacjentem interpretującym to jako „w końcu mam energię”. Mapa cyklu to nie ćwiczenie samoanalityczne — to narzędzie decyzyjne, kiedy zadzwonić do lekarza, kiedy odwołać podróż, kiedy poprosić bliską osobę o nadzór nad finansami.

01 → Pięć faz cyklu — wzorzec ogólny

1 · PRODROM (1-4 TYG. PRZED)

Subtelne zmiany rytmu i nastroju. Często bagatelizowane jako „zmęczenie” lub „dobry tydzień”. **Okno największej skuteczności interwencji.** Wystarczają zmiany zachowania (sen, ograniczenie stresorów, kontakt z osobą bliską).

2 · NARASTANIE (KILKA DNI-2 TYG.)

Objawy stają się wyraźne dla Ciebie i otoczenia. Wgląd jeszcze częściowo zachowany. **Wymaga kontaktu z lekarzem** — często potrzebna korekta dawki, czasem dołączenie leku ratunkowego.

3 · SZCZYT (DNI-TYGODNIE)

Pełnoobjawowy epizod. Wgląd ograniczony lub zniesiony. **Plan kryzysowy w działaniu.** Możliwa hospitalizacja. Decyzje przejmuje osoba bliska zgodnie z wcześniejszym planem.

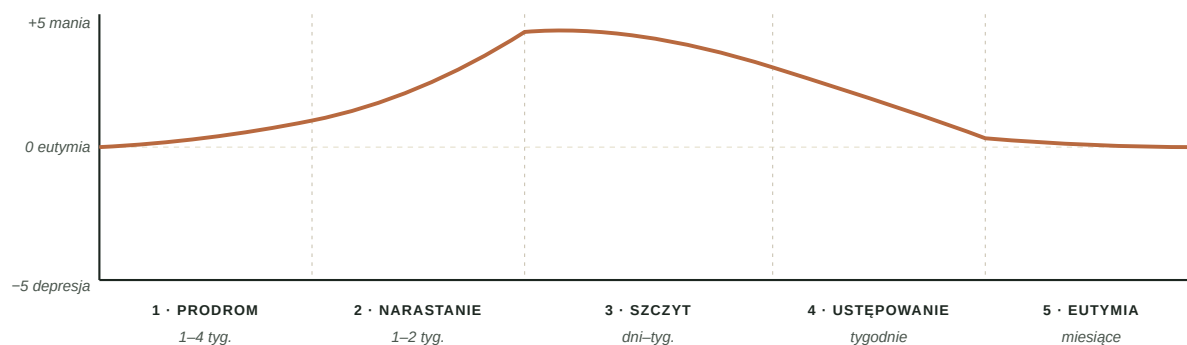
4 · USTĘPOWANIE (TYGODNIE)

Objawy słabną, ale stan jeszcze niestabilny. **Najwyższe ryzyko nawrotu** w tej fazie — błędne uznanie „już jestem zdrowy/-a” i odstawienie leków. Wymagana ostrożność w decyzjach życiowych.

5 · POWRÓT DO EUTYMII (MIESIĄCE)

Stabilizacja. Funkcjonowanie wraca do bazy. To jest moment na **analizę epizodu**: jakie były wyzwalacze, jakie sygnały zignorowałeś/-am, co kolejnym razem rozpoznasz wcześniej. Aktualizuj listę sygnałów ostrzegawczych i plan kryzysowy.

02 Typowa krzywa epizodu manii



Cykl depresji ma analogiczny kształt, ale krzywa biegnie w dół — szczyt w okolicy $-4/-5$. Niektóre epizody mają fazę mieszaną w okolicy szczytu lub ustępowania (krzywa oscyluje wokół 0).

03 Mój ostatni epizod — zmapowanie

FAZA	CZAS TRWANIA	CO DZIAŁO SIĘ W TEJ FAZIE	CO ZROBIŁBYM/-ABYM INACZEJ
<i>Prodrom</i>			
<i>Narastanie</i>			
<i>Szczyt</i>			
<i>Ustępowanie</i>			

Klucz: w retrospektywnych wywiadach Lam i wsp. (2003) 92% pacjentów ChAD potrafiło zidentyfikować prodromy poprzedzające ostatni epizod — ale tylko 14% rozpoznawało je w czasie ich trwania. To okno percepcji jest do nauczenia. Każdy zmapowany epizod podnosi prawdopodobieństwo, że następny rozpoznasz wcześniej. Ta karta to nie raport pośmiertny — to materiał szkoleniowy dla Twojego przyszłego ja.